

TEMA 4.17 • DERMATOLOGÍA

Dermatosis Asociadas a la Luz Solar

PERFIL EUNACOM 6.01.1.008

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trastornos Ampollosos Severos de la Piel EUNACOM

Se trata de desórdenes vesiculobulosos sistémicos muy agresivos cuya lesión primaria anatómica universal resulta siempre en el surgimiento abultado epidérmico en burbujas con pérdida de barrera limitante: Ampollas desprendidas crudas diseminadas en el recubrimiento estéril corporal.

1. El Pénfigo y el Penfigoide (Diferencias Autoinmunitarias Histopatológicas Vitales)

Patologías letales reaccionarias crónicas mediadas bajo ataques por Anticuerpos puros del huesped. Son potencialmente septicémicas si diseminan al perder barrera protectora de envoltura vital.

- **A. El Penfigo (Vulgar):**
- **Fisiopatología Autoinmune y Signografía Biopsiada (Inmunofluorescencia Directa):** Su estroma resulta purulento celularmente porque el ataque cruzado inmunológico deposita Anticuerpos directamente destinados en disolver a **La Unión y cemento INTER-Queratinocitos celular en el medio de toda la Epidermis plana** aislando sus sustratos celulares.
- **Cuadro Clínico Morfológico de Ruptura Superficial:** Al soltarse celularmente su ancla superficial en la base matriz; el agua penetra empujando manifestando macro cráteres. Brotan y se expanden grandes e inmensas **Buldas/Ampollas Flácidas y de tejido aguado fofo sueltas y "Extremadamente Fáciles de Romper"** frente a brisas o presiones minúsculas de sábanas leves al rozar.
- **Signo Patognomónico Excluyente N°1 Derivativo (SIGNO DE NIKOLSKY POSITIVO +):** Maniobra clínica semiológica confirmatoria. Traccionar elástica de forma pasiva digital a piel aledaña aparentemente "Sana", instiga que despegue la epidermis fofa por delante del dedo. Lo comparten el Síndrome de Steven Johnson/NET y la infecciosa Síndrome Piel Escaldada.
- **B. El Penfigoide (Ampollosos):**
- **Fisiopatología Autoinmune (Inmunofluorescencia Directa):** Mutación cruzada autoinmune cuyo auto-anticuerpo selectivo destruye exclusivamente sustratos más profundos celulares anclados bajando perimetral general en **La Unión inferior base de la Lámina Basal adherente dérmica** completa total.
- **Cuadro Clínico Morfológico Basal Firme:** Al estar levantado con todo el revestimiento epidérmico arriba íntegro acribillador elástico, brotan y engruesan **Buldas/Ampollas extremadamente TENSAS y Esféricas duras y redondas**. Se torna inmensamente gruesa e íntegra resultando casi que imposibles "difíciles dolorosas de romper" naturalmente al toque de rutina basal leve sin aguja.
- **Signo Patognomónico Excluyente Secundario:** Al realizar frotado ciego rudo de tracción elástica periférica estéril de arrastre (Signo de Nikolsky) este cruza con ser un rasgo general netamente y puramente Negativo (**Signo de NIKOLSKY NEGATIVO -**).

(Manejo Basitáreo General del Pénfigo/Penfigoide Inmunes Letales: Conllevan siempre derivos a internación agresiva corticoidea general. Los **Corticoides Sistémicos Orales base a Altísimas Dosis inmensas** asociado pilar al uso inmaculadamente estéril de prevención Infecciones curativo en general intrahospitalario antibióticas curaciones o letales sepsias post descamativas).

2. Epidermolisis Bulosa (Genopatía: Los Niños con "Piel de Mariposa")

- **Fisiopatología Congénita / Falla Estructural Extrema del Gestante Causal:** Esta es excluyente de la autoinmunidad celular pura perimetral adquirida; se trata trágicamente en un fallo **TOTALMENTE GENÉTICO** desde el embrión de fábrica (Mutaciones estructurales masivas en la Lámina Basal colágena epidérmica basal) de adherencia estomacal superficial nacidos sin cemento genérico unial. - **Cuadro Clínico de Diseminación Mecánica Constante Severo:** Debutan en la cama hospitalaria perinatal neonatológicamente e intraparto en el Recién Nacido. Sometidos de base a crueles torturas físicas generales de roces, dado que ante el "Más Mínimo traumatismo frotado inofensivo caricia o presión pasiva anatómica del pañal", explotan ampollas hemorrágicas o se descarna y desprende el tejido piel crudo sangrante letal subyacente frágil como las alas de las mariposas general desproporcional limitante. - **Pronóstico Causal Genético Estricto Letal Discapacitante y Falla Manejable:** No existe terapia de remisión base pastillas. Generan cicatrizaciones deformantes sinequias amputarias fusionadoras generales limitantes brutales; muchas genéticas nulas mutadas fallecen letales puramente en infecciones septicémicas general antes del año de remisión pasadas lactancias sin defensas de piel con dolor base paliativo morfinos. El único rescate integral utópico investigacional hoy crudo por desatar reposa sus limitantes bajo los laboratorios inyectando paralelos focos de **Terapia de Genética reconstructiva**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Cuál es la diferencia principal entre una reacción fototóxica y una fotoalérgica?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Dermatosis Asociadas a la Luz Solar. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las reacciones fototóxicas se producen en cualquier persona con suficiente fármaco y luz UV.
- Las quinolonas, tetraciclinas e isotretinoína son los fármacos fototóxicos más importantes.
- Las reacciones fotoalérgicas requieren sensibilización previa con mecanismo inmunológico.
- La fitofotodermatitis ocurre por contacto de plantas o jugos cítricos con piel expuesta al sol.
- La erupción solar polimórfica es idiopática y produce pápulas en zonas fotoexpuestas.
- El tratamiento general incluye fotoprotección y corticoides tópicos.
- La diferencia clave es que la fototóxica afecta a todos con suficiente exposición y la fotoalérgica no.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DERMATOSIS ASOCIADAS A LA LUZ SOLAR)**PREGUNTA 1**

¿Cuál es la diferencia principal entre una reacción fototóxica y una fotoalérgica?

- A)** La fototóxica requiere sensibilización previa y la fotoalérgica no requiere contacto previo
- B)** La fototóxica afecta a cualquier persona con suficiente exposición y la fotoalérgica requiere sensibilización
- C)** La fototóxica produce ampollas y la fotoalérgica produce solo eritema sin ampollas
- D)** La fototóxica solo se produce por fármacos sistémicos y la fotoalérgica solo por tópicos
- E)** La fototóxica es idiopática y la fotoalérgica siempre tiene una causa identificable

PREGUNTA 2

¿Cuáles son los fármacos más importantes que pueden causar fotosensibilidad tóxica?

- A)** Los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno y naproxeno sódico
- B)** Las quinolonas, las tetraciclinas y la isotretinoína como fármacos fototóxicos
- C)** Los inhibidores de la bomba de protones como omeprazol y pantoprazol
- D)** Los betabloqueantes como el propranolol y el atenolol en dosis altas
- E)** Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina en tratamiento crónico

PREGUNTA 3

¿Qué es la fitofotodermatitis?

- A)** Una quemadura solar severa producida por exposición prolongada sin protección
- B)** Una reacción fotoalérgica por contacto de plantas o cítricos con piel expuesta al sol
- C)** Una erupción polimórfica idiopática que aparece en primavera al inicio de la exposición
- D)** Un tipo de dermatitis atópica que empeora con la exposición a la radiación UV
- E)** Una infección bacteriana de la piel desencadenada por el calor solar excesivo

RESUMEN: DERMATOSIS ASOCIADAS A LA LUZ SOLAR

Las dermatosis asociadas a la luz solar incluyen varios cuadros que deben conocerse. La quemadura solar es la reacción aguda más frecuente y produce eritema, dolor y eventualmente ampollas. La erupción solar polimórfica es una fotodermatosis idiopática que produce pápulas pruriginosas en zonas fotoexpuestas y se trata con corticoides tópicos y fotoprotección. Las reacciones fototóxicas son daño directo por la combinación de un fármaco más radiación ultravioleta, se producen en cualquier persona con suficiente exposición, y los fármacos más importantes son las quinolonas, las tetraciclinas y la isotretinoína. Las reacciones fotoalérgicas en cambio requieren sensibilización previa y tienen un mecanismo inmunológico, y el ejemplo más conocido es la fitofotodermatitis producida por plantas como el litre o jugos de frutas como limones y limas que al entrar en contacto con la piel expuesta al sol generan una reacción. En todos los casos el tratamiento incluye protección solar y corticoides tópicos.